

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU

Tarih:

1) PROJENİN ADI

Tip I Diyabet Tanılı Çocuklar, Sağlıklı Kardeşleri ve Annelerinin Ebeveyn Tutumlarına Yönelik Algılarının Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi ve Kardeşler Arası İlişkilerin İncelenmesi

2) ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ

- | | |
|---|--|
| ☐ Klinik İlaç Araştırması | ☐ Deneysel Araştırma |
| ☒ Anket Çalışması | ☐ Epidemiyolojik Araştırma |
| ☐ İlaç Dışı Klinik Araştırma | ☒ Diğer (Niteliksel Çalışma) |

3) ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRMALARDA, KURUM DIŞINDAKİ MERKEZLERİN:

Adı:

Adresi:

4) SORUMLU ARAŞTIRMACIN

ADI: Eren Özek

UNVANI: Profesör Doktor

GÖREVİ: Öğretim Üyesi

İMZASI:

5) YARDIMCI ARAŞTIRMACILARIN

ADI: Belma Haliloğlu

UNVANI: Doçent Doktor

GÖREVİ: Öğretim Üyesi

İMZASI:

ADI: Özlem Murzoğlu Kurt

UNVANI: Uzman Doktor

GÖREVİ: Doktora Öğrencisi

İMZASI:

6) PROJENİN YÜRÜTÜLECEĞİ KLİNİK/BİLİM/ANABİLİM DALI

ADI ADRESİ: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Pediatri Bilim Dalı

T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

TEL: (0216) 777 58 36

7) DESTEKLEYEN KURULUŞUN (VARSA)

ADI:

ADRESİ:

YETKİLİLERİ:

8) ÇOK MERKEZLİ ARAŞTIRMALARDA ARAŞTIRMA KOORDİNATÖRÜNÜN

ADI:

KURULUŞU:

GÖREVİ:

UNVANI:

9) ÇALIŞMANIN GEREKÇESİ/AMACI:

Kronik hastalıkları olan çocuklar, sadece bu hastalıklarla değil, aynı zamanda kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla da yaygın olarak karşılaşmaktadırlar. Ayrıca hastalık nedeniyle okul, arkadaşlıklar, ders dışı aktiviteler, sosyal yaşam ve normal psikolojik gelişim önemli derecede etkilenmektedir. Kronik hastalığı olan çocuklar, psikiyatrik bozukluklar ve sosyal problemler açısından üç kat artmış risk taşımaktadır.¹

Kronik hastalığı olan çocukların ebeveynleri de derinden etkilenir: Fiziksel olarak yorgun, az enerjili ve zihinsel olarak hüsrana uğramış, endişeli, kızgın, çaresiz ve umutsuzlardır. Sürekli olarak çocuklarına bakmak zorunda kalmalarından dolayı kendilerini sosyal olarak izole olmuş ve bitkin hissetmektedirler.²

Kronik hastalığı olan bir çocuğu büyütme süreci, etkili bir şekilde ebeveynlik yapma becerisini ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesini değiştirebilir. Bu ebeveynler, sağlıklı çocukların ebeveynlerine göre çocuk yetiştirme sorumluluklarıyla daha fazla karşı karşıyadır. Ebeveyn enerjisini daha fazla sayıda sorumluluğa dağıtmak, bazı ebeveynlik görevleri için daha az zaman veya enerji bırakabilir. Kronik hastalığı olan bir çocuğun ebeveynleri, çocuğun hastalığının gerekleriyle başa çıkmada bunalmış ve yetersiz hissedebilir ve bu nedenle çocuklarından geri çekilebilir. Bazı ebeveynler, beklentilerini karşılamadığı için çocukla ilgili hayal kırıklığı ve öfke de hissedebilirler. Stres faktörlerine bir yanıt olarak, kronik hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin yüksek düzeyde depresif belirtiler gösterdiği bulunmuştur. Ebeveyn depresyonu, azalan ebeveyn şefkati ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesinde düşüş ile ilişkilendirilmiştir.³

Ebeveynlik stilleri, çocukların zorluklarla başa çıkma tarzlarının önemli bir belirleyicisidir. Birincil bakım verenler olarak ebeveynler, çocuklarının şimdiki ve gelecekteki duygusal sağlığının, kişiliğinin, karakterinin, esenliğinin, sosyal ve bilişsel gelişiminin ve akademik performansının üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bir çocuğun davranışı, farklı ebeveynlik stillerine göre gelişir ve değişir.⁴ Geçmişten günümüze birçok kuramcı farklı kavramsallaştırmalar ile ebeveynlik tarzlarını açıklamaya çalışmıştır. İlk olarak Diana Baumrind 1960'larda yaptığı çalışmalar sonrasında ebeveynlik tarzlarını otoriter, izin verici ve demokratik olmak üzere üç temel boyutta incelemiştir. Perris ve arkadaşları, yaptığı çalışmalarda çocukların ebeveynlerin yetiştirme tarzlarına ilişkin algısının önemli olduğunu vurgulamışlar ve ebeveynlerin çocuk yetiştirme tarzlarına ilişkin (yetişkin) çocukların algılarını değerlendiren bir ölçek olan Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği'ni (Egna Minnen Barndoms Uppfostran - EMBU) geliştirmişlerdir.⁵ Daha sonra yetişkinler için geliştirilen bu ölçeğin geriye dönük yorumlama sınırlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla çocuk versiyonları oluşturulmuştur. Gerek EMBU, gerekse de alanda kullanılan diğer ebeveynlik stili ölçeklerinin çoğu için tanımlanan ana eksenler "Kontrol ve Aşırı Koruma"ya karşı "Özerklik", "Sevgi ve Sıcaklık"a karşı ise "Reddedilme ve Düşmanlık"tır.⁶

Furman ve Giberson'a göre; ebeveynle çocuklar arasındaki etkileşimler, kardeş ilişkilerine model teşkil ettiğinden ebeveyn ve çocuk ilişkisinin genel yapısı, kardeş ilişkisinin niteliğini de etkilemektedir. Kardeş ilişkilerinin niteliği, çocuğun sosyal hayatındaki uyuma ve aile içindeki bireysel gelişim sürecine etki eder. Bunun yanı sıra kardeş ilişkilerinin, bilişsel ve dil gelişimine de etkisi vardır. Çünkü kardeşler arasındaki duygusal bağlılık, anne baba ve çocuk arasındaki bağlılıktan sonra ikinci sırada yer alır.⁷ Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde kaygı, depresyon, sosyal geri çekilme ve somatik şikayetleri içeren içselleştirme sorunlarıyla sıklıkla karşılaşmaktadır.⁸ Kronik hastalığı olan çocukların kardeşleriyle ilişkileri konusunda bilgi eksiklikleri vardır. Gerek bu çocuklara yönelik ebeveyn tutumlarının, gerekse de bu kardeşler arasındaki ilişkilerin niteliğinin sağlıklı çocuk ve sağlıklı kardeşleri ile kıyaslanması ile bu süreçlere ışık tutulabilir.

Bu amaçla, çocukluk çağında sık karşılan bir kronik hastalık olan tip I diyabet tanılı çocukları çalışma alanı olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ebeveynlik tarzının, diyabet yönetimindeki uygulamaların (glisemik kontrol) sonuçlarını etkilediği gösterilmiştir.⁹ Çalışmamızdan elde edilecek sonuçların bu hastaların optimal yönetimine de katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda tip I diyabet hastası çocuklar ile

bunların sağlıklı kardeşlerinin ve annelerinin ebeveyn tutumlarına yönelik algılarını değerlendirmeyi ve kardeşler arası ilişkilerin niteliğini incelemeyi planlamaktayız.

Araştırmamız ile şu sorulara yönelik cevaplar edinmeyi amaçlamaktayız:

- Tip I diyabet tanısı almış çocukların ebeveyn tutumlarına (Duygusal Sıcaklık, Reddetme, Aşırı Koruma, Karşılaştırma) yönelik algıları ile bu çocukların sağlıklı bir kardeşinin ve bir kontrol grubunun (sağlıklı kardeşi/kardeşleri olan sağlıklı çocuklar) algıları arasındaki muhtemel farklılıklar nelerdir?
- Tip I diyabet tanılı çocuklar ile bunların sağlıklı kardeşleri arasındaki ilişkiler “Sıcaklık/Yakınlık”, “Bağlantı Statü/Güç”, “Çatışma” ve “Rekabet” parametreleri açısından nasıl şekillenmektedir? Hasta - sağlıklı çocuk kardeş ilişkilerinin kontrol grubu çocukların kardeş ilişkilerine yönelik değerlendirmeleri ile farkları nelerdir?
- Tip I diyabet tanılı çocukların annelerinin kendi ebeveyn tutumlarına yönelik algıları ile hasta çocuk sahibi olmayan kontrol grubundaki annelerin algıları arasında ne tür farklılıklar vardır?
- Tip I diyabetli çocuk annelerinin duygu durumları nasıl etkilenmektedir ve depresyon varlığı ile şiddeti algılanan ebeveyn tutumlarını nasıl şekillendirmektedir?
- Hasta çocuk, sağlıklı kardeş ve sağlıklı kontrol grubu çocukların ebeveynlerinin tutumlarına yönelik algıları ile kendi annelerinin öz değerlendirmeleri karşılaştırıldığında hangi parametreler arasında tutarlılık ve/veya tutarsızlıklar vardır?

Çalışmamızda ayrıca diyabetli gruptan rastgele seçilen anneler ve çocukları ile niteliksel araştırma amaçlı yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerin amacı hasta çocuklar, anneleri ve sağlıklı kardeşlerinin içinde bulundukları süreci, birbirleriyle olan ilişkilerini nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini derinlemesine betimleyebilmektir. Böylelikle olayların ve olguların gerçekçi bir ortamda bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacak; olaydaki aktörlerin bakış açıları daha iyi anlaşılabilir.

Çalışma sonucunda elde edilecek bulgular, kronik hastalığı olan çocuk anne babalarının etkili bir şekilde ebeveynlik yapma becerisini ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesini yükseltebilecek müdahalelere dayanak sağlayacaktır.

10) UYGULANACAK YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER:

Araştırmaya T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'nda tip I diyabet tanısıyla takip edilen 7 - 13 yaş grubu hastalar ve bunların aynı yaş grubundaki sağlıklı bir kardeşi ile anneleri; kontrol grubu olarak da aynı kurumun Hasta Çocuk Kliniğine başvuran 7 - 13 yaş grubu çocuklar ve anneleri dahil edilecektir. Tüm çocuk ve annelerin demografik ve tıbbi bilgileri bir form aracılığıyla toplanacaktır.

Ebeveynlik tutumlarının ölçülmesinde *Egna Minnen Beträffande Uppfostran* (My Memories of Upbringing - EMBU) ölçeğinin kısa formunun hem çocuk hem de ebeveyn formlarının Sümer ve arkadaşları tarafından uyarlanan Türkçe versiyonları olan “Kısaltılmış Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu (s-EMBU-C)” ve “Kısaltılmış Ebeveyn Tutumları Ölçeği Ebeveyn Formu (s-EMBU-P)” kullanılacaktır.¹⁰ EMBU ilk olarak Perris ve arkadaşları tarafından yetişkinlerin ebeveynlerinin çocuk yetiştirme davranışlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Orijinal ölçek bir dizi uyarlamadan geçirilerek bakım verenlerin şimdiki zamanda kendi çocuk yetiştirme davranışlarına ilişkin algılarını ölçen bir yetişkin versiyonu (EMBU-P) ile çocukların ebeveynlerinin şimdiki çocuk yetiştirme davranışlarına ilişkin algılarını ölçen bir çocuk versiyonu (EMBU-C) geliştirilmiştir. Ek olarak, kültürlerarası araştırmalarda kullanılmak üzere üç alt ölçekten (Duygusal Sıcaklık, Reddetme ve Aşırı Korumacı) oluşan kısa bir EMBU formu (s-EMBU) da mevcuttur. Yapılan çalışmalar, EMBU-C'nin 7-13 yaş arası çocuklar için uygun bir ebeveynlik tutumu değerlendirme aracı olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. Gerek farklı kültürlerde tutarlı sonuçlar sunması, gerekse de Türk kültürüne uygunluğu

açısından incelenmiş ve modifiye edilmiş olması nedeniyle çalışmamızda EMBU ölçeğini kullanmayı planlamaktayız. EMBU'yu tercih etmemizin bir diğer gerekçesi ise çocuk ve ebeveyn versiyonu arasındaki farklılık ya da tutarlılık düzeyinin de bir ölçüt olarak kullanılabilmesidir.

Çalışmamıza katılacak 7 - 13 yaş arası çocuklara uygulamayı planladığımız Sümer ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Türk aile ortamına uygun 27 maddelik bir ölçek olan s-EMBU-C ölçeğinde 4 parametre skorlanmaktadır: Bunlar, orijinal EMBU-C'de yer alan "Duygusal Sıcaklık" (9 madde), "Reddetme" (7 madde) ve "Aşırı Koruma" (6 madde) ile birlikte yazarlar tarafından Türkçe ölçeğe eklenmiş yeni bir alt ölçek olan "Karşılaştırma" (5 madde) şeklindedir. Ölçeğin maddeleri 4'lü Likert tipinde cevaplandırılmaktadır. (1 = Hayır, hiçbir zaman, 4 = Evet, her zaman). Alt ölçeklerin iç tutarlık güvenirlik katsayıları (Cronbach's alpha) .49 ile .69 arasında değişmektedir. Ölçeğin puanlanması, her bir alt boyuttan alınan yüksek puanlar, o alt boyutun ölçtüğü özelliğin kişide arttığını göstermektedir.

Çalışmamıza katılacak annelere uygulamayı planladığımız ve yine aynı araştırmacılar tarafından Türk kültürüne uygun bir biçimde uyarlanan s-EMBU-P ölçeği toplam 29 maddeden ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır: "Duygusal Sıcaklık" (9 madde), "Aşırı Koruma" (7 madde), "Reddetme" (8 madde) ve yazarlar tarafından ilave edilmiş olan "Karşılaştırma" (5 madde). Annelerden bu anketteki maddeleri 6'lı Likert ölçeğinde doldurmaları istenecektir. (1 = Hiçbir Zaman'dan 6 = Her Zaman'a). Ebeveyn versiyonu için iç tutarlılık güvenirlik katsayıları (Cronbach's alpha) .75 ile .82 arasında değişmektedir.¹¹

Kronik hastalığı olan çocukların ebeveynlerinde depresyon ile karşılaşabilmektedir. Çalışmamıza katılan annelerin depresyon durumlarını ölçümlemek için Beck Depresyon Envanteri kullanılacaktır.

Örneklem boyutu belirlenirken sözü edilen ölçeklerin her bir alt ölçeği için %95 güven aralığı ve %80 güç ile OpenEpi (Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health, Version 3.01) yazılımı kullanılarak hesaplamalar yapılmış; daha önce yapılmış olan çalışmalar¹²⁻¹⁵ baz alındığında örneklem büyüklüğü her iki grup için en az 14'er kişi olarak hesaplanmıştır. Alt ölçekler için hesaplanacak skorların değişkenliği nedeniyle 14 kişilik minimum örneklem 30'a arttırılmasının ideal olacağı varsayılmış ve buradan hesapla 120 tip I diyabetli çocuğun çalışmaya dahil edilmesi planlanmıştır. Bu plana dayanarak hasta çocuğun sağlıklı kardeşleri (n=120), bunların anneleri (n=120), kontrol grubu olarak sağlıklı çocuklar (n=120) ve bunların anneleri (n=120) de çalışmamıza dahil edilecektir.

Çalışmamıza katılan hasta-sağlıklı çocuk çiftleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin incelenmesi için 1985 yılında Furman ve Buhrmester tarafından geliştirilmiş ve Apalaçi (1996) tarafından Türkçe'ye çevrilerek uyarlama çalışması yapılmış "Kardeş İlişkileri Anketi (Sibling Relationship Questionnaire)" kullanılacaktır.^{7,16} Bu anket, dört genel boyuttan oluşmaktadır: Sıcaklık/Yakınlık boyutu; olumlu ilişki, şefkat, arkadaşlık, benzerlik, samimilik, kardeşi takdir etme, kardeş tarafından takdir edilme alt boyutlarından oluşmaktadır. Likert tipi 5 dereceli ("Hemen hemen hiç" yanıtına 1 puan, "Oldukça az" yanıtına 2 puan, "Biraz" yanıtına 3 puan, "Oldukça fazla" yanıtına 4 puan, "Çok çok fazla" yanıtına 5 puan) ve 18 maddeden oluşan bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .90 olarak bulunmuştur. Bağlantı Statü/Güç boyutu; kardeşi eğitme, kardeş tarafından eğitime, kardeş üzerinde baskınlık, kardeşin baskınlığı alt boyutlarından oluşmaktadır.. Likert tipi (5 dereceli) ve 10 maddeden oluşan bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .78 olarak bulunmuştur. Çatışma boyutu; tartışma, düşmanlık ve yarışma alt boyutlarından oluşmaktadır.. Likert tipi (5 dereceli) ve 10 maddeden oluşan bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .87 olarak bulunmuştur. Rekabet boyutu; anne yanlılığı ve baba yanlılığı alt boyutlarının toplam puanlarının ortalaması ile elde edilmiştir. Likert tipi (5 dereceli) ve 10 maddeden oluşan bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) ise .73 olarak bulunmuştur. Türkçe formunun güvenirlik çalışması, ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden 30 öğrenci üzerinde uygulanarak yapılmıştır. Her bir alt boyut için yapılan güvenirlik analizleri sonuçların iç tutarlılığın yüksek olduğunu göstermiştir.

Araştırmacı tarafından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılacak ve verilerin kalite kontrolü yapıldıktan sonra istatistiksel analizler için SPSS 22.0 programı kullanılacaktır. Tanımlayıcı istatistikler, yüzde, ortalama, standart sapma değerleriyle verilecektir. Oluşturulan gruplar arasındaki farkları

incelemek için kategorik değişkenler için Ki-Kare testi, sayısal değişkenler için ikili gruplarda Student-t Test'i, ikiden fazla gruplarda One-Way ANOVA testi kullanılacaktır. $p < 0.05$ anlamlı kabul edilecektir.

Çalışmanın ikinci kısmında niteliksel analiz yöntemleri kullanılacaktır. Örneklem belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniğinde takipte olan ve çalışmaya katılım kriterlerini karşılayan hastaların çalışmaya katılım onayı veren ailelerinden toplam 6 aile rastgele seçilerek yapılacaktır. Tip 1 DM tanılı hasta, hastanın sağlıklı kardeşi ve annesi ile ayrı ayrı birebir 15-20 dakikalık görüşmeler (her aile için toplam yaklaşık 60 dakika) araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilecektir. Daha önceden belirlenmiş sorular (hastalığın aile ilişkilerini nasıl etkilediğine dair) doğrultusunda görüşmeler yapılacaktır. Görüşmeler bir moderatör ve bir gözlemci varlığında gerçekleşecek olup, döküm analizlerin yapılabilmesi için katılımcıların (ebeveynlerin) izni dahilinde ses kaydı alınacaktır. Görüşmeler sırasında katılımcıların vücut dilleri not edilecek, ses kayıtları metine dönüştürülecek; sonrasında metin içerisinde sık vurgulanan ifadeler işaretlenerek tematik çerçeve oluşturulacaktır. Tematik doygunluğa erişilememesi halinde görüşme sayısı arttırılacaktır.

11) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA SÜRESİ

Başlangıç tarihi: Şubat 2023

Verilerin değerlendirme süresi: 4 Ay

Bitiş tarihi: Şubat 2024

A- YAPILACAĞI YER

☒ HASTANE

☐ SAHA

☒ POLİKLİNİK

☐ SAĞLIK OCAĞI

☐ DİĞERLERİ (lütfen belirtiniz)

B- GÖNÜLLÜLERİN NİTELİĞİ

☒ SAĞLAM

☒ HASTA (HASTALIĞIN ADI: Tip I Diyabet)

☒ ÇOCUK (10-18 YAŞ)

C- GÖNÜLLÜLERLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Çalışmaya Alınacak Minimum Gönüllü Sayısı	Toplam	Yaş Aralığı
Hasta	30	7 - 13
Sağlıklı	90	7 - 13
Diğer (Anneler)	60	+18

12) ARAŞTIRMAYA DAHİL OLMA, HARIÇ TUTULMA VE ARAŞTIRMADAN ÇIKARILMA KRİTERLERİ

(Örneğin dahil olma için 45-60 yaş hipertansif hasta, hariç tutulma için renovasküler hipertansiyon ve çıkarılma için araştırmaya dahil edilmiş hipertansif hastada inme gelişmesi gibi).

DAHİL OLMA KRİTERLERİ

Hasta Çocuklar Grubu

- Tip I diyabet tanısı almış olmak
- 7 - 13 yaş arasında olmak
- 7 - 13 arası en az bir sağlıklı kardeşe sahip olmak
- Her iki ebeveynin hayatta olması

- Sorulara doğru yanıt verebilecek yetkinlikte Türkçe bilmek

Hasta Çocukların Sağlıklı Kardeşleri Grubu

- 7 - 13 yaş arasında olmak
- Sorulara doğru yanıt verebilecek yetkinlikte Türkçe bilmek

Hasta Çocukların Anneleri Grubu

- Çocukları ile birlikte yaşıyor olmak
- Çocukların birincil bakım verenlerinden biri olmak

Sağlıklı Kardeş/Kardeşleri Olan Sağlıklı Çocuklar Kontrol Grubu

- 7 - 13 yaş arasında olmak
- 7 - 13 arası en az bir sağlıklı kardeşe sahip olmak
- Her iki ebeveynin hayatta olması
- Sorulara doğru yanıt verebilecek yetkinlikte Türkçe bilmek

Sağlıklı Çocukların Anneleri Grubu

- Çocukları ile birlikte yaşıyor olmak
- Çocukların birincil bakım verenlerinden biri olmak

HARIÇ BIRAKILMA KRİTERLERİ

Hasta Çocuklar Grubu

- Tip I diyabet tanısı dışında başka bir kronik hastalığı ya da engelliliği olması
- Annenin veya babanın engelliliği olması

Hasta Çocukların Sağlıklı Kardeşleri Grubu

- Herhangi bir kronik bir sağlık problemi veya engelliliği olması

Hasta Çocukların Anneleri Grubu

- Eşinin hayatta olmaması
- Engelliliği olması

Sağlıklı Kardeş/Kardeşleri Olan Sağlıklı Çocuklar Kontrol Grubu

- Herhangi bir kronik bir sağlık problemi veya engelliliği olması
- Herhangi bir kardeşinde kronik bir sağlık problemi veya engelliliği olması
- Annenin veya babanın engelliliği olması

Sağlıklı Çocukların Anneleri Grubu

- Eşinin hayatta olmaması
- Engelliliği olması

REFERANSLAR

1. Cadman D, Boyle M, Szatmari P, Offord DR. Chronic illness, disability, and mental and social well-being: findings of the Ontario Child Health Study. *Pediatrics*. 1987;79(5):805-813.
2. Caicedo C. Families with special needs children: family health, functioning, and care burden. *J Am Psychiatr Nurses Assoc*. 2014;20(6):398-407.
3. Pinquart M. Do the parent-child relationship and parenting behaviors differ between families with a child with and without chronic illness? A meta-analysis. *J Pediatr Psychol*. 2013;38(7):708-721.
4. Baumrind D. Parental Disciplinary Patterns and Social Competence in Children. *Youth Soc*. 1978;9(3):239-267.

5. Perris C, Jacobsson L, Lindström H, von Knorring L, Perris H. Development of a new inventory assessing memories of parental rearing behaviour. *Acta Psychiatr Scand*. 1980;61(4):265-274.
6. Castro J, de Pablo J, Gómez J, Arrindell WA, Toro J. Assessing rearing behaviour from the perspectives of the parents: a new form of the EMBU. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 1997;32(4):230-235.
7. Furman W, Buhrmester D. Children's perceptions of the qualities of sibling relationships. *Child Dev*. 1985;56(2):448-461.
8. Göbel A, Henning A, Möller C, Aschersleben G. The Relationship between Emotion Comprehension and Internalizing and Externalizing Behavior in 7- to 10-Year-Old Children. *Front Psychol*. 2016;7:1917.
9. Anderson BJ. Parenting styles and parenting practices in pediatric diabetes. *Diabetes Care*. 2011;34(8):1885-1886.
10. Sümer N, Gündoğdu-Aktürk E, Helvacı E. Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış. *Türk Psikoloji Yazıları*. 2010;13(25):42-59.
11. Sümer N, Selçuk E, Günaydın G. Mediating role of parenting between marital communication and child problem behaviors. İçinde: Relations Studies Association International Conference; 2006.
12. Özyurek O. *A Comparative Study of Children with Specific Learning Disorder: Symptom Severity, Perception of Parenting Styles, Parental Stress, Competence and Homework Situation*,. M.Sc. Hacettepe University; 2019.
13. Caliskan A. *The Relationship Between Mothers' Parenting Styles and Emotion Understanding Of Children Through The Mediator Role Of Children's Perceived Parenting Styles Of Their Mothers*. M.Sc. Middle East Technical University; 2015.
14. Saritas D. *Psychological Well-Being Of Adolescents: Maternal Rearing Behaviors, Basic Personality Traits And Emotion Regulation Processes*. Ph.D. Middle East Technical University; 2012.
15. Pala Saglam S. *School-aged children's experience and expression of shame and guilt: The role of age, gender, context, parenting and socioeconomic status*. M.Sc. Boğazici University; 2016.
16. Apalaci V. *Psychological adjustment and sibling relationships of older brothers and sisters of children with pervasive developmental disorders*. M.Sc. Bogazici University; 1996.

TAAHHÜTNAME

İlgili Makama,

“Tip I Diyabet Tanılı Çocuklar, Sağlıklı Kardeşleri ve Annelerinin Ebeveyn Tutumlarına Yönelik Algılarının Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi ve Kardeşler Arası İlişkilerin İncelenmesi” başlıklı çalışmaya katılan aşağıda imzası olan araştırmacılar olarak Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesinin son versiyonunu ve Sağlık Bakanlığı’nın yeni yayınlamış olduğu İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu / İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu’nu okuduğumuzu, çalışmanın Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, İKU/İLU kriterlerine uygun olarak yürütüleceğini, çalışmadan doğabilecek her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğimizi ve çalışmayla ilgili olarak çalışmaya katılan tüm birim ve elemanların bilgilendirildiğini beyan ve taahhüt ederiz.

Sorumlu Araştırmacı:

Prof.Dr. Eren Özek

İmza:

Yardımcı Araştırmacılar:

Doç.Dr. Belma Haliloğlu

İmza

Uzm.Dr. Özlem Murzoğlu Kurt

İmza:

ARAřTIRMA BÜTÇESİ

1/2

Giderlerin Türü

I A.	Personel Giderleri:	
	a) Arařtırmacılara ödenecek ücretler	
	b) Yardımcı personele ödenecek ücretler	Yoktur
B.	Arařtırma kurumuna yapılacak ödeme	Yoktur
C.	Gönüllülere yapılacak ödemeler	Yoktur
	a) Doğrudan ödemeler	Yoktur
	b) Gönüllülerin masraflarının geri ödenmesi şeklindeki ödemeler	Yoktur
D.	Arařtırma yerindeki hizmet alımları (danıřmanlık, testler, bilgisayar işlemleri vb. ödemeler)	Yoktur
E.	Arařtırma yeri dışında hizmet alımları (arařtırma yeri dışından danışmanlık, test, işlem, baskı, iletişim vb ödemeler)	Yoktur
F.	Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri	2.000 TL
G.	İlaç, kimyasal, kırtasiye vb sarf malzeme alımları	2.000 TL
H.	Sigortalama giderleri (ve/veya tazminat karşılığı bloke para)	Yoktur
	a) Gönüllüler için	Yoktur
	b) Varsa arařtırıcılar için	Yoktur
I.	Seyahat giderleri (bilimsel ve yönetsel toplantılara katılmak gibi)	Yoktur
J.	Şerefiye veya telif ücreti şeklinde ödemeler	Yoktur
K.	Sözleşmeli arařtırma kurumu varsa ona yapılacak ödemeler	Yoktur
L.	Diğer ödemeler (Türünü belirtiniz)	Yoktur

GENEL TOPLAM

4.000 TL

II	Mal olarak verilmiş ilaç, kimyasal, teçhizat ve / veya malzeme varsa bunların türünü ve miktarını ayrı bir yerde açıklayınız.	Arařtırma ile ilgili ilaç yoktur.
----	---	-----------------------------------

ARAřTIRMA BÜTÇESİ

2/2

GELİRLERİN KAYNAĞI

** Kaynaklar

A. Destekleyici	Yoktur
B. Arařtırma fonları (TÜBİTAK, Üniversite Arařtırma Fonu, DPT vs gibi)	Yoktur
C. Kurum genel bütçesi	Yoktur
D. Diğer kaynaklar (kurum dışı harcamalar)	4.000 TL

GENEL TOPLAM 4.000 TL

Sorumlu Arařtırmacının

ADI SOYADI - ÜNVANI: Prof.Dr. Eren Özek

TARİH:

İMZA:

Gider kalemlerinin kapsadığı toplam giderler gerektiğinde alt kalemler haline ayrılarak yazılabilir ve giderlerin birden fazla kaynak tarafından karşılanması durumunda hangi kalem ve / veya kalemlerin hangi kaynaktan karşılanacağı belirtilmelidir.

**** ÖNEMLİ NOT:** Çalışma kapsamında uygulanacak olan ilaçların (kontrol veya karşılaştırma ilacı dahil) ve yapılacak testlerin, laboratuvar tetkiklerinin ve muayenelerin bedelleri hiçbir surette Sosyal Güvenlik Kurumu, kamuya ait fon ve bütçelerden veya özel sağlık sigortalarından karşılanamaz veya kişiye ödettirilemez. Bu bedeller arařtırmacı(lar) veya projeyi destekleyen kişi(ler) ve kuruluş(lar) tarafından ödenir.

“TİP I DİYABET TANILI ÇOCUKLAR, SAĞLIKLI KARDEŞLERİ VE ANNELERİNİN EBEVEYN TUTUMLARINA YÖNELİK ALGILARININ SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARDEŞLER ARASI İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ” ADLI ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

LÜTFEN OKUYUNUZ!

- Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız.
- Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce:
 - Çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve
 - Kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir.
- Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz.
- Sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.

ÇALIŞMANIN AMACI NEDİR?

- Çalışmamızda tip I diyabet hastası çocuklar ile bunların sağlıklı kardeşlerinin ve annelerinin ebeveyn tutumlarına yönelik algılarını değerlendirmeyi ve kardeşler arası ilişkilerin niteliğini incelemeyi amaçlamaktayız. Böylelikle elde edilecek bulgular ile kronik hastalığı olan çocuk anne babalarının etkili bir şekilde ebeveynlik yapma becerisini ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesini yükseltebilecek müdahalelere dayanak sağlamayı hedeflemekteyiz.

KATILMA KOŞULLARI NELERDİR?

- Çalışmamıza T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'nda tip I diyabet tanısıyla takip edilen 7 – 13 yaş grubu hastalar ve bunların aynı yaş grubundaki sağlıklı bir kardeşi ile anneleri; kontrol grubu olarak da aynı kurumun Hasta Çocuk Kliniğine başvuran 7 – 13 yaş grubu kronik hastalığı olmayan çocuklar ve anneleri dahil edilecektir.

NELER UYGULANACAK VE NASIL BİR UYGULAMA YAPILACAK?

- Çalışmamıza katılan çocuklara “Kısaltılmış Ebeveyn Tutumları Ölçeği Çocuk Formu (s-EMBU-C)” ve annelerine “Kısaltılmış Ebeveyn Tutumları Ölçeği Ebeveyn Formu (s-EMBU-P)” uygulanacaktır. Aynı zamanda çalışmamıza katılacak çocuklara “Kardeş İlişkileri Anketi (Sibling Relationship Questionnaire)” ve annelere de “Beck Depresyon Envanteri” uygulanacaktır. İlaveten çalışmaya katılan diyabetli çocuk, anneleri ve sağlıklı kardeşleri arasından rastgele seçilecek 6 aile ile niteliksel araştırma amacıyla yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır.

KATILIMCI SAYISI NEDİR?

- Araştırmada yer alacak katılımcı sayısı tahmini olarak 200 kişidir.

ÇALIŞMANIN SÜRESİ NEDİR?

- Çalışmamızın tahminen 12 ay sürmesi planlanmıştır.

ÇALIŞMAYA KATILMA İLE BEKLENEN OLASI YARAR NEDİR?

- Çalışmamıza katılarak kronik hastalığı olan çocuklar ve bunların sağlıklı kardeşlerine yönelik ebeveynlik tutumlarının incelenmesine katkı sağlayacak, böylelikle bu çocukların ve bakım verenlerinin yaşam standartlarını arttırabilecek müdahalelere destek olabileceksiniz.

ÇALIŞMAYA KATILMA İLE BEKLENEN OLASI RİSKLER NEDİR?

- Çalışmamıza katılan gönüllüler ve çocukları için herhangi bir risk ön görmemekteyiz.

ARAŞTIRMA SÜRESİNCE ÇIKABİLECEK SORUNLAR İÇİN KİMİ ARAMALIYIM?

- Çalışmamızın sorumlu araştırmacısı Uzm.Dr. Özlem Murzoğlu Kurt'a ulaşabilirsiniz. (ozlem.murzoglu@gmail.com)

ÇALIŞMA KAPSAMINDA GİDERLER KARŞILANACAK MIDIR?

- Çalışma kapsamında bir gider kalemi öngörülmemektedir.

ÇALIŞMAYA KATILMAM NEDENİYLE HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILACAK MIDIR?

- Herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

ÇALIŞMAYA KATILMAYI KABUL ETMEM VEYA ARAŞTIRMADAN AYRILMAM DURUMUNDA NE YAPMAM GEREKİR?

- Bu araştırmada yer almak tamamen sizin isteğinize bağlıdır.
- Araştırmada yer almayı reddedebilirsiniz.
- Araştırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır.
- Çalışmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından çıkarılmanız durumunda sizinle ilgili veriler bilimsel amaçla kullanılmayacaktır.

KATILMAMA İLİŞKİN BİLGİLER KONUSUNDA GİZLİLİK SAĞLANABİLECEK MİDİR?

- Size ait tüm tıbbi ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır ve araştırma yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir, ancak araştırmanın izleyicileri yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir, ancak bu bilgiler gizli tutulacaktır, yazılı bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun imzalanması ile söz konusu erişime izin vermiş olacaksınız.
- Bilgiler kamuoyuna açıklanmayacak; araştırma sonuçlarının yayınlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacak, araştırma konusuyla ilgili sizi etkileyebilecek yeni bilgiler elde edildiğinde zamanında bilgilendirileceksiniz.

KATILIMCININ BEYANI:

"TİP I DİYABET TANILI ÇOCUKLAR, SAĞLIKLI KARDEŞLERİ VE ANNELERİNİN EBEVEYN TUTUMLARINA YÖNELİK ALGILARININ SAĞLIKLI KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARDEŞLER ARASI İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ" KONULU ÇALIŞMA

- Sayın Dr. ÖZLEM MURZOĞLU KURT tarafından Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde ve T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya ben ve çocuğum/çocuklarım "katılımcı" (denek) olarak davet edildim.
- Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılabileceğine inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.
- Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilir ve/veya çocuğumu/çocuklarımı çalışmadan çekebilirim. Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekilmeyi önceden bildirmemin uygun olacağını bilincindeyim. Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi amacıyla araştırmacı tarafından araştırmadan çıkartılabileceğimi de biliyorum. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğimi biliyorum.
- Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dr. ÖZLEM MURZOĞLU KURT'u, 0 542 150 44 83 - ozlem.murzoglu@gmail.com - Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 3 Uphill Towers A-30 Ataşehir İSTANBUL telefon ve adresinden arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımına ve hekim ile olan ilişkiye herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.
- Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalamış bulunduğum bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir.

GÖNÜLLÜ ONAM FORMU:

TARİH:

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Çalışmaya çocuk/çocuklarımla katılmasını kabul ve müsaade ediyorum:

- ☐ Diyabet Hastası Çocuğum
- ☐ Diyabet Hastası Çocuğumun Kardeşi
- ☐ Kontrol Grubu Sağlıklı Çocuğum

Gönüllünün:

Adı-Soyadı:

Telefonu:

Adresi:

İmzası:

Açıklamaları Yapan Araştırmacının:

Adı-Soyadı:

İmzası:

Rıza Alma İşlemine Başından Sonuna Kadar Tanıklık Eden Kuruluş Görevlisinin:

Adı-Soyadı:

İmzası:

Görevi: